EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81951
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-05 08:38:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: FRESIA DEL CARMEN NOVOA ESPINOZA			RUN	: 7.341.969-7
F.Nac	: 03-07-2022	Edad	: 1 AÑO, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-04-02	Fecha Egreso	: 2024-04-05 08:38:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) ITU en tratamiento (C Glabrata)
2) AKI resuelta
3) DM2 IR
4) HTA
5) Enf de alzheimer
6) AMputacion supracondilea Izq 2°
7) Limitacion severa ABVD
8) EPOC
9) ACv secuelado
10) Vegiga neurogenica

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta en SU el 01/04 por cuadro de deposiciones diarreicas, nauseas, vomitos de 24 hrs de evolucion, sin antec de trasngresion alimentaria al interrogatgorio dirigido, examenes de lab al ingreso se evidencia crea 2,1; osmolaridad 302; PCR 75,8; Gb 15,9; pH 7,35, NA/K/Cl 123/5.8/97. Ex fisico se describe sin uso de muscualtura accesoria, abdomen BDI, extremidades sin edema, sin taquipnea, sin cianosis, orina con leucos > 100 por campo. Se decide ingreso para tratamiento
Durante ingreso se inicia terapia ATB con cefalosporina de 3° generacion, se procede a volemizacion por AKI prerrenal 2° a deshidratacion, con mejoria de funcion renal e hidroelectrolitica.
URC con desarrollo de Candida Glabrata, se decide inicio de terapia antifungica
Paciente estable dentro de su condicion, personal de enfermeria refiere que pasa buena noche, con episodios de desorientacion fluctuantes, con necesidad de contencion fisica. Con HGT fluctuantes, entre 97 y 338 en estas ultimas 24 hrs, requerimientos de insulina cristalina

Examenes de lab -> crea 1,4; calcio 8,7, fosforo 4,4; lactato 0,7; PCR 85,2; Na/K/Cl 138/4.9/115; GSV pH 7,32, HCO3 11,1

Ex fisico -> Vigil, sigue ordenes de forma parcial, mucosas rosadas, levemente deshidratadas (menor cuantia en comparativa a ayer), llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades anquilosadas, con hipotrofia de tren inferior, se visualiza amputacion supracondilea Izq

paciente actualmente cursando su dia N° 4 hospitalizada, dia N° 4 de ceftriaxona, dia N° 2 de fluconazol, en condiciones de continuar tratamiento via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Renal/hidroelectrolitico: Actualmente AKI resuelta 2° a cuadro de deshidratacion, sin conflicto actual
4) Infeccioso: Con parametros inflamatorios levemente al alza, actualmente en tratamiento antifungico por orina patologica, se completara terapia ATB conc efalosporina por 7 dias, se continuara seguimiento de paciente via HODOm
5) Metabolico: Se procede a reinicio de terapia insulinica, evaluar ajuste de posologia segun respueta de paciente via HODOm

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentado 30°
2. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 3 dias
4. Omeprazol 20 mg al dia VO por 12 hrs
5. Quetiapina 25 mg VO SOS por 12 dias
6. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 12 dias
7. Fluconazol 200 mg al dia VO por 12 dias
8. Bisoprolol 2,5 mg al dia VO por 2 dias
9. Acido folico 5 mg al dia VO por 12 dias
10. Insulina NPH 18 UI AM - 10 UI PM SC
11. Examenes de control 08/04
12. KNT motora una vez al dia
13. Cuidados de enfermeria prevencion UPP

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO